

Síndrome de Stevens-Johnson (SJS) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o Síndrome de Lyell)

(Basado en: Guías Clínicas MINSAL Chile 2023–2024, British Association of Dermatologists (BAD) 2024, European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2024, UpToDate 2025, Fitzpatrick's Dermatology 2023 y Apunte de Dermatología aportado.)

1. Introducción y relevancia clínica

El Síndrome de Stevens-Johnson (SJS) y la Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o Lyell) constituyen **reacciones mucocutáneas graves** inducidas por fármacos, potencialmente letales, que representan un **continuo de severidad**:

- **SJS**: desprendimiento epidérmico <10% superficie corporal.
- **SJS/NET solapado**: 10–30%.
- **NET**: >30%.

Ambas entidades se caracterizan por **necrosis epidérmica difusa**, **erosiones mucosas** y **compromiso sistémico severo**.

Relevancia clínica

- **Mortalidad**: SJS ≈ 5–10%, NET ≈ 30–50%.
 - **Principales causas**: reacciones farmacológicas graves, especialmente a **alopurinol**, **lamotrigina**, **carbamazepina**, **sulfas**, **AINES tipo oxicam** y **antibióticos β-lactámicos**.
 - Constituye una **emergencia dermatológica vital**, que requiere **suspensión inmediata del fármaco causal**, **derivación a UCI o unidad de quemados**, y **manejo de soporte integral**.
 - En **EUNACOM**, el objetivo es **reconocer precozmente** los signos cardinales (fiebre, erosiones mucosas, ampollas flácidas, dolor desproporcionado) y aplicar el **manejo inicial correcto**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo inmunológico

- Reacción de **hipersensibilidad tipo IVc**, mediada por **linfocitos T citotóxicos (CD8+)**.
 - El fármaco o su metabolito se une a proteínas del queratinocito, activando T CD8+ → liberación de **perforina, granzima B, granulolisina y Fas-ligando (FasL)** → **apoptosis masiva de queratinocitos**.
 - Resultado: **necrosis epidérmica extensa y desprendimiento cutáneo**.
-

2.2. Factores desencadenantes

Categoría	Ejemplos frecuentes
Anticonvulsivantes	Lamotrigina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital
Antibióticos	Sulfamidas, penicilinas, cefalosporinas, quinolonas
AINes (oxicams)	Piroxicam, tenoxicam
Alopurinol	En ancianos o insuficiencia renal
Antirretrovirales	Nevirapina

2.3. Factores de riesgo

- **Genéticos:**
 - HLA-B*1502 → riesgo con carbamazepina (asiáticos).
 - HLA-B*5801 → riesgo con alopurinol (asiáticos y latinoamericanos).

- **Inmunosupresión:** VIH, neoplasias, trasplantes.
 - **Infecciones previas** (p. ej. *Mycoplasma pneumoniae*).
 - **Polifarmacia y edad avanzada.**
-

2.4. Cronología

- Aparece típicamente **1–3 semanas** después del inicio del fármaco (más precoz si reexposición).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Fase prodrómica

- Duración: 1–3 días antes de lesiones cutáneas.
 - Síntomas inespecíficos: fiebre >38°C, odinofagia, tos, conjuntivitis, artralgias, malestar general.
 - Dolor cutáneo (“piel sensible o ardorosa”) → signo temprano y muy útil.
-

3.2. Fase cutáneo-mucosa

- **Lesiones iniciales:** máculas eritematosas oscuras o violáceas, dolorosas, confluentes.
 - **Evolución:** ampollas flácidas → erosiones extensas → desprendimiento epidérmico.
 - **Signo de Nikolsky positivo:** la epidermis se separa con presión tangencial.
 - **Localización:** tronco, cara, extremidades proximales.
 - **Mucosas:** afectadas en 90–100% (oral, ocular, genital, nasal, anal).
 - Estomatitis dolorosa, blefarconjuntivitis, erosiones vulvoperineales.
-

3.3. Diferencias clínicas

Característica	SJS	NET
% superficie afectada	<10%	>30%
Mortalidad	5–10%	30–50%
Ampollas	Pequeñas, localizadas	Extensas y flácidas
Mucosas	Siempre afectadas	Siempre, más graves
Curso	Subagudo	Fulminante

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Eritema multiforme mayor	Lesiones en “diana”, sin necrosis epidérmica ni grandes ampollas.
DRESS	Exantema morbiliforme + eosinofilia + hepatitis, sin desprendimiento epidérmico.
SSSS (piel escaldada estafilocócica)	Neonatos y niños, sin compromiso mucoso; cultivo + a <i>S. aureus</i> .

Quemadura térmica

Antecedente evidente, sin compromiso mucoso.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Diagnóstico clínico

- Antecedente de fármaco de riesgo + fiebre + lesiones ampollares y erosivas + compromiso mucoso.

Exámenes

- **Hemograma:** anemia, linfopenia, leucocitosis variable.
- **PCR, VSG:** elevadas.
- **PFH y función renal:** alteradas si compromiso sistémico.
- **Biopsia de piel:** necrosis epidérmica con mínima inflamación dérmica → confirmatoria.
- **Electrolitos y gases:** evaluar deshidratación e hiponatremia.
- **Cultivos cutáneos y hemocultivos:** si hay signos de infección secundaria.

Escala pronóstica SCORTEN

Parámetro	1 punto si presente
Edad >40 años	✓
Cáncer o enfermedad maligna	✓

% despegamiento >10% ✓

FC >120/min ✓

Urea >10 mmol/L ✓

Glucosa >14 mmol/L ✓

Bicarbonato <20 mmol/L ✓

Interpretación:

0–1 pt: mortalidad <10% | 2 pts: 12% | 3 pts: 35% | ≥4 pts: >50%.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / BAD / EADV)

5.1. Principios generales

- **Suspender de inmediato** el fármaco sospechoso.
 - **Hospitalizar en UCI o unidad de quemados.**
 - **Medidas de soporte intensivo:**
 - Control térmico (28–30 °C).
 - Hidratación EV y balance hídrico estricto.
 - Control del dolor y nutrición enteral precoz.
 - Protección de mucosas (ocular, oral, genital).
-

5.2. Cuidados de soporte

Área	Manejo
Piel	Apósitos no adherentes; no romper ampollas intactas; evitar debridamientos agresivos.
Ocular	Lágrimas artificiales, pomadas antibióticas; evaluación por oftalmología en <24 h.
Oral/genital	Enjuagues antisépticos, anestésicos tópicos, higiene rigurosa.
Nutrición	Sonda nasogástrica; aporte calórico alto; control de glucemia.
Analgesia	Paracetamol, opioides leves (evitar AINES).

5.3. Terapias específicas

Terapia	Comentarios / dosis
Corticoides sistémicos	Útiles en fases iniciales si se inician precozmente; prednisona 1 mg/kg/día o metilprednisolona EV (≤ 3 días). Evitar uso prolongado (> 5 días).
Inmunoglobulina IV (IVIG)	2–3 g/kg en 3–5 días; bloquea Fas-FasL; útil si < 48 h desde inicio.
Ciclosporina	3–5 mg/kg/día por 7–10 días; disminuye mortalidad y días de reepitelización (nivel A).

Etanercept	Dosis única 50 mg SC; estudios muestran beneficios similares a ciclosporina.
-------------------	--

Antibióticos	Solo ante infección documentada; no profilaxis rutinaria.
---------------------	---

En Chile y Latinoamérica, la **ciclosporina** es la terapia inmunomoduladora más usada por evidencia y costo-efectividad.

5.4. Rehabilitación y seguimiento

- **Curaciones diarias** bajo ambiente estéril.
- **Monitoreo de función renal, hepática y respiratoria.**
- **Seguimiento oftalmológico y dermatológico** hasta resolución completa.
- Educación sobre **evitar el fármaco causal y notificación farmacológica.**

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Frecuencia	Comentario
Infección bacteriana secundaria	Alta	Principal causa de muerte (S. aureus, Pseudomonas).
Desequilibrio hidroelectrolítico	Común	Por pérdida transdérmica.
Complicaciones oculares	20–50%	Queratitis, sinequias, ceguera.
Insuficiencia respiratoria	Grave	Por compromiso bronquial.

Sepsis / Shock séptico

Mortalidad
elevada.

Secuelas psicológicas

Frecuentes

Estrés postraumático, ansiedad.

Pronóstico:

Depende de SCORTEN, edad y rapidez en la suspensión del fármaco. Mortalidad promedio: **SJS 5–10%, NET 25–50%**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **SJS y NET son el mismo espectro**, se diferencian por extensión cutánea.
 2. **Compromiso mucoso + dolor + fiebre + ampollas flácidas** = sospecha inmediata.
 3. **Fármacos más asociados**: alopurinol, lamotrigina, carbamazepina, sulfas, AINES.
 4. **Signo de Nikolsky positivo** y erosiones en mucosa oral y genital son claves.
 5. **Suspender fármaco causal + hospitalizar en UCI/quemados** es la prioridad.
 6. **Ciclosporina e IVIG** tienen mejor evidencia que corticoides prolongados.
 7. **Evite antibióticos profilácticos innecesarios.**
-



Errores comunes

- Diagnosticar como “alergia leve” o eritema multiforme.
- Retrasar suspensión del fármaco.

- Tratar ambulatoriamente sin derivar.
 - Iniciar corticoides prolongados o antibióticos profilácticos sin indicación.
 - No proteger mucosas (ocular, genital).
 - No calcular **SCORTEN** ni estratificar riesgo.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **SJS y NET son reacciones graves a fármacos** con necrosis epidérmica y erosiones mucosas.
2. Se diferencian por **porcentaje de piel afectada**: SJS <10%, NET >30%.
3. **Fármacos de alto riesgo**: alopurinol, lamotrigina, carbamazepina, sulfas, AINES oxicam.
4. **Cuadro clínico**: fiebre, dolor cutáneo, erosiones mucosas, ampollas flácidas, Nikolsky positivo.
5. **Manejo inicial**: suspender fármaco, hospitalizar, rehidratación, protección mucosas.
6. **Ciclosporina o IVIG** son terapias inmunomoduladoras de elección precoz.
7. **Mortalidad elevada** si diagnóstico y tratamiento se retrasan; la **derivación temprana salva vidas**.